



MÁS ALLÁ DEL PRISMA

Capítulo 8: Psico-oncología y Cuidados Paliativos

Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental

Introducción: La palabra ante el límite y la desarticulación del cuerpo

El prejuicio histórico

Durante décadas, el psicoanálisis ortodoxo mantuvo cierta reticencia a intervenir en los servicios de oncología u hospitalización general, bajo el prejuicio de que el aparato psíquico debilitado por una enfermedad orgánica grave no era apto para el trabajo asociativo o que la urgencia médica invalidaba la labor de la palabra.

La clínica contemporánea demuestra lo contrario

Cuando una enfermedad oncológica irrumpe en la vida de un sujeto, no solo desorganiza su anatomía, sino que pulveriza las coordenadas de su existencia. El cuerpo deja de ser ese continente silencioso que habitábamos sin cuestionar para convertirse en un territorio hostil, doloroso y amenazante.

El modelo de la **Clínica de la Convergencia** postula que el analista no puede replegarse en la comodidad aséptica del consultorio privado. Es menester tender un puente indisoluble entre la metapsicología del duelo anticipado y el alivio neurobiológico del dolor, comprendiendo que el sufrimiento físico y el psíquico operan como una experiencia unitaria.

- ❏ La palabra no cura el tumor, pero restituye la legalidad subjetiva, devolviéndole al paciente la dignidad de ser autor de su historia incluso en los tramos más complejos de la finitud.

SECCIÓN 1

Metapsicología de la Finitud y el Impacto del Diagnóstico Orgánico Grave

Para profundizar rigurosamente en la intervención psicoanalítica dentro del campo de la psico-oncología y los cuidados paliativos, es imperativo abandonar la ilusión de que el aparato psíquico opera al margen de la materialidad destructiva del cuerpo.

El colapso traumático radical

Cuando el sujeto recibe el diagnóstico de una enfermedad orgánica grave o terminal, no se enfrenta meramente a un evento médico desafortunado; experimenta un colapso traumático radical que sacude los cimientos mismos de su economía narcisística y de su representación del mundo.

Dos ejes de análisis

La metapsicología de la finitud se articula en torno a dos ejes clínicos fundamentales: **(1)** el trauma somático y el colapso del escudo antiestímulo (*Reisschutz*), y **(2)** la herida narcisística y la amenaza de aniquilación del yo.

El trauma somático y el colapso del escudo antiestímulo (*Reisschutz*)

Freud conceptualizó el trauma como aquella irrupción de estímulos cuya intensidad desborda por completo la capacidad del aparato psíquico para ligarlos (*Bindung*) y tramitarlos. En la irrupción de una patología orgánica grave, el cuerpo —que solía funcionar como el soporte silencioso y casi transparente del yo (el "yo-piel", el continente de la experiencia)— se convierte súbitamente en un intruso amenazante.

Perforación del escudo

El dolor físico, la pérdida de autonomía, la alteración de la imagen corporal y la cercanía de la muerte actúan como un estallido que perfora violentamente el escudo antiestímulo (*Reisschutz*).

Desamparo estructural

El sujeto queda sumergido en un estado de desamparo estructural (*Hilflosigkeit*), donde las defensas neuróticas habituales —la represión, el aislamiento, la intelectualización— se revelan insuficientes para contener la inundación de angustia.

La herida narcisística y la amenaza de aniquilación del yo

El colapso del narcisismo

El diagnóstico oncológico opera como una afrenta narcisística absoluta. El narcisismo, sostenido en la ilusión de continuidad vital y en la promesa inconsciente de la propia inmortalidad, se desploma ante la evidencia de la finitud.

El sujeto no solo sufre por el daño biológico inminente, sino por la **pérdida anticipada de sus inversiones**: los proyectos futuros, los roles sociales, los vínculos significativos y la propia identidad construida a lo largo de los años.

El papel del analista — Clínica de la Convergencia

En este escenario, el papel del analista bajo el modelo de la Clínica de la Convergencia no es interpretar "fantasías inconscientes" en el sentido tradicional, sino **ofrecerse como un continente simbólico y real**.

El consultorio o la cabecera del paciente se transforman en el espacio donde el horror, la rabia, la desesperanza y el duelo anticipado pueden ser nombrados, evitando que el sujeto quede confinado al silencio paralizante del terror.

Neurobiología del Dolor Total: La Convergencia entre el Sufrimiento Físico y el Psíquico

La metapsicología de la finitud y el trauma somático encuentra su correlato ineludible en la neurobiología contemporánea del dolor y el estrés crónico. En el ámbito de los cuidados paliativos, el concepto de "**dolor total**" —acuñado por **Cicely Saunders**— cobra una dimensión rigurosamente científica cuando analizamos cómo el cerebro procesa simultáneamente el daño tisular y el sufrimiento subjetivo.

Dolor físico

Daño tisular, inflamación, nocicepción

Dolor psíquico

Duelo, desamparo, pérdida vincular

Dolor total

Experiencia unitaria e indisoluble

La superposición de las redes neuronales del dolor físico y social

Las investigaciones en neuroimágenes y neurociencias afectivas han demostrado de manera categórica que el dolor físico y el dolor psíquico comparten los mismos circuitos subcorticales.

Ínsula anterior y corteza cingulada anterior (ACC)

Se activan tanto cuando el cuerpo experimenta un daño físico agudo como cuando el sujeto atraviesa la angustia devastadora del desamparo o la exclusión vincular.

El dolor como experiencia unitaria y total

El cerebro no distingue netamente entre la herida del cuerpo y la herida del lazo social. Esto explica científicamente por qué un paciente con una enfermedad oncológica avanzada ve multiplicado exponencialmente su sufrimiento físico cuando está atravesado por el aislamiento, el terror al abandono o la culpa inconsciente.

El agotamiento alostático y el secuestro del sistema neuroendocrino

Ante el avance de una enfermedad orgánica grave y la inminencia de la finitud, el organismo humano es sometido a una **sobrecarga alostática extrema**.

Eje HPA y sistema nervioso simpático

El eje **HPA (Hipotalámico-Pituitario-Adrenal)** y el sistema nervioso simpático operan en un estado de descarga incesante, inundando el sistema de cortisol y catecolaminas.

Consecuencias del baño crónico de estrés

- Deterioro de la función inmunológica
- Agotamiento de las reservas metabólicas del paciente
- Alteración de la plasticidad sináptica
- Compromiso severo de la corteza prefrontal
- Estados de confusión, delirio hiperactivo o aplanamiento depresivo profundo

La intervención convergente frente al dolor total

Comprender esta arquitectura neurobiológica es lo que habilita a la **Clínica de la Convergencia** a articular de forma virtuosa el tratamiento médico-paliativo con la intervención analítica conversacional.

1

Modulación de base

El psicofármaco y el analgésico de precisión actúan como moduladores que desactivan el secuestro amigdalino y reducen el ruido del dolor tisular.

2

Recuperación de la ventana afectiva

Al disminuir la inundación neurobiológica del estrés, el paciente recupera la ventana de tolerancia afectiva necesaria para poder conversar y tramitar sus duelos pendientes.

3

Dignidad subjetiva y palabra propia

El paciente puede despedirse, habitar sus últimos tiempos con dignidad subjetiva y recuperar la autoría de su historia en los tramos finales de la existencia.

📌 La articulación virtuosa entre analgesia precisa, control farmacológico del sufrimiento somático e intervención analítica conversacional constituye el núcleo operativo de la Clínica de la Convergencia en el campo paliativo.

Fuentes

Material visual del capítulo

[Capítulo 8.jpg](#)

Marco teórico

Más allá del Prisma — Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental. Capítulo 8: Psico-oncología y Cuidados Paliativos.